

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008246-51.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: HELIDA CRISTINA DOS SANTOS MENDES

DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE COM SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA RENAL. RISCO DE PERDA DE ÓRGÃO E COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO RENAL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. LEI Nº 12.732/2012. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5008246-51.2025.4.02.5101

510015593788 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5008246-51.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: HELIDA CRISTINA DOS SANTOS MENDES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face do deferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 2ª VF de Duque de Caxias [evento 4, DESPADEC1, dos autos de origem], com o seguinte teor:

"(...) Ante a farta comprovação da gravidade do quadro de saúde do autor e da urgência na transferência da autora para hospital que disponha de estrutura para a realização da biópsia necessária à elucidação diagnóstica, bem como ao oferecimento do tratamento oncológico que se faça necessário, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para que os réus promovam, no prazo urgente de 3 (três) dias, a transferência da autora para hospital classificado como UNACON/CACON apto à imediata realização da biópsia e do fornecimento do tratamento oncológico que se mostrar indicado, a critério da equipe médica, sob pena de multa diária que fixo em R\$200,00 (duzentos reais), limitada a R\$10.000,00 (dez mil reais) para cada ente que compõe o polo passivo."

Em apertada síntese, a autora narra ter sido diagnosticada com **Neoplasia Maligna do Rim (CID10 C64)**, e estar internada no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz desde o dia 02/11/2024, onde aguarda transferência para nosocômio com serviço de oncologia, destacando que caso não seja submetida imediatamente ao tratamento adequado, há eminente risco de perda do rim, comprometimento definitivo de filtração do sangue, dependência definitiva de hemodiálise e morte.

O juízo de origem destaca, em sua decisão, que o laudo emitido por médico do SUS (Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz) [evento 1, OFIC5], apesar de não confirmar o diagnóstico de neoplasia maligna, informa que é *"altamente suspeito de tumor renal ainda sem diagnóstico"* e que o nosocômio em que ela está internada não realiza a biópsia necessária ao encaminhamento para o tratamento adequado.

Neste sentido, a União entende não terem sido demonstrados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, faltando à demanda a probabilidade do direito. Ademais, pontua ofensa à isonomia e risco de irreversibilidade da medida. Pretende a concessão do efeito suspensivo.

Indeferimento do efeito suspensivo [evento 3, DESPADEC1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"A ausência de diagnóstico é, justamente, a causa de pedir da demanda. Analisando a documentação anexa à inicial, consta documento da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro classificando a autora como "paciente oncológico" [evento 1, DOC11], além de laudo do médico-assistente que indica a alta probabilidade do diagnóstico, que, todavia, não foi feito porque o Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz não apresenta condições para tal [evento 1, OFIC5].

Como a decisão recorrida bem pontua, o médico-assistente, além de definir como altamente provável o diagnóstico, destaca a urgência da transferência, confirmação do quadro clínico de oncologia e início do tratamento, ante o risco de perda do rim pela autora [evento 1, OFIC5].

Não suficiente, a documentação dos autos de origem indica que a solicitação de transferência foi realizada em 27/11/2024, mas até meados de janeiro/2025 a autora ainda aguardava por vaga, ante a negativa de todos os Hospitais Federais consultados [evento 1, OFIC7].

Vale pontuar que o prazo disposto pela Lei 12.732/2012 - segundo a qual o paciente tem direito ao primeiro tratamento oncológico em até 60 dias - não se aplica perfeitamente à espécie, porquanto a autora ainda aguarda confirmação do diagnóstico, mas a documentação carreada aos autos é suficiente para aplicação analógica do dispositivo, haja vista a alta probabilidade de neoplasia maligna.

Assim, considerando que a autora teve sua transferência solicitada em 27/11/2024, considero esgotado o prazo de 60 dias fixado pela Lei 12.732/2012.

*Por todo o exposto, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar **INDEFERIMENTO do efeito suspensivo**."*

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Não suficiente, deve-se pontuar que o presente recurso de medida de urgência tem por escopo a análise de tutela provisória de urgência em cognição não exauriente, razão pela qual o art. 300 e seguintes Código de Processo Civil exige a probabilidade do direito e não a sua certeza.

Nesta guisa, são suficientes os documentos que compõem a inicial nos autos de origem, no sentido do diagnóstico altamente provável de neoplasia maligna, inviabilizado pela falta de aparato técnico no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz.

Ainda que diferente fosse, a pretensão autoral foi confirmada pelo parecer do NAT-Jus [evento 8, PARECER1], onde é confirmada a indicação do tratamento oncológico para o quadro clínico da autora, na medida em que *"altamente suspeito de neoplasia maligna do rim (Evento 1, OFIC5, Página 2)"*.

Ademais, o documento técnico confirma a urgência da pretensão autoral, sob risco de perda do rim:

"Ressalta-se que em documento médico (Evento 1, OFIC5, Páginas 2 e 3), foi solicitado urgência para o atendimento oncológico da Autora, sob risco de perda irreversível de órgão/função. Assim, salienta-se que a demora exacerbada no atendimento oncológico da Autora, poderá comprometer o prognóstico em questão."

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.